Açık Apendektomi İş Akışı (Detaylı Adım Listesi)

1. **Cilt ve Karın Duvarına Giriş**
   1.1. **Adım 1:** Sağ alt kadranda McBurney (veya Elliot) insizyonu
   1.2. **Adım 2:** Cilt altı yağ dokusu diseke edilir.
   1.3. **Adım 3:** Camper ve Scarpa fasya tabakaları açılır.
   1.4. **Adım 4:** Dış oblik aponevrozu ortaya konur.
   1.5. **Adım 5:** Dış oblik aponevrozu insize edilir.
   1.6. **Adım 6:** Kas lifleri künt diseksiyonla ayrılır.
   1.7. **Adım 7:** Transversalis fasya açılır.
   1.8. **Adım 8:** Periton pens ile tutulur.
   1.9. **Adım 9:** Periton küçük bir kesi ile açılır.
   1.10. **Adım 10:** Periton açıklığı makas ile genişletilir.
2. **Ekartasyon**
   1.1. **Adım 11:** Farabeuf ekartörü yerleştirilir.
   1.2. **Adım 12:** Gerekirse Roux ekartörü yerleştirilir.
   1.3. **Adım 13:** Cerrahi saha ekspoze edilir.
3. **Çekuma Ulaşılması**
   1.1. **Adım 14:** Çekum bulunur.
   1.2. **Adım 15:** Çekum atravmatik **Babcock pens** ile tutulur.
   1.3. **Adım 16:** Çekum yara dışına alınır.
4. **Appendiksin Bulunması**
   1.1. **Adım 17:** Tenialar takip edilerek appendiks bulunur.
   1.2. **Adım 18:** Appendiks ucu **Babcock pens** ile tutulur.
5. **Yapışıklık Varsa**
   1.1. **Adım 19:** Yapışıklıklar değerlendirilir.
   1.2. **Adım 20:** Yapışıklıklar Lahey yardımı ile gerilir.
   1.3. **Adım 21:** Yapışıklıklar makas veya monopolar koter ile ayrılır.
6. **Mezappendiks Diseksiyonu**
   1.1. **Adım 22:** Mezappendiks ortaya konur.
   1.2. **Adım 23:** Mezappendiks damarları bağlanır.
   1.3. **Adım 24:** Mezappendiks makas ile kesilir.
7. **Appendiks Köküne Hazırlık**
   1.1. **Adım 25:** Appendiks kökü tamamen ortaya çıkarılır.
   1.2. **Adım 26:** 3/0 ipek hazırlanır.
   1.3. **Adım 27:** Appendiks kökü çevresine purse-string (çevre) sütürü konur.
8. **Appendiks Kökünün Bağlanması**
   1.1. **Adım 28:** Appendiks kökü **2/0 Poliglaktin (Vicryl)** ile bağlanır.
   1.2. **Adım 29:** Bağ sağlamlığı kontrol edilir.
9. **İşaret Pensi Yerleştirilmesi**
   1.1. **Adım 30:** Bağın distal tarafına düz dişsiz işaret pensi konur.
10. **Appendiksin Kesilmesi**
    1.1. **Adım 31: No:15 bistüri** hazırlanır.
    1.2. **Adım 32:** İşaret pensinin distalinden appendiks kesilir.
11. **Güdüğün Temizlenmesi**
    1.1. **Adım 33:** Kesilen yüzey batikonlu fındık tampon ile silinir.
    1.2. **Adım 34:** Kirlenmiş bistüri ucu değiştirilir.

12. Güdüğün Gömülmesi

1.1. **Adım 35:** Önceden hazırlanmış purse-string sütürü sıkılır.
1.2. **Adım 36:** Appendiks güdüğü çekum içine gömülür.
1.3. **Adım 37:** Çevre sütürü düğümlenir.

13. Spesimenin Gönderilmesi

1.1. **Adım 38:** Çıkarılan appendiks patoloji kabına alınır.
1.2. **Adım 39:** Patoloji kabı etiketlenir.

14. Hemostaz

1.1. **Adım 40:** Cerrahi saha kanama açısından kontrol edilir.
1.2. **Adım 41:** Gerekli bölgelerde hemostaz sağlanır.

15. Yıkama

1.1. **Adım 42:** Karın içi izotonik serum ile yıkanır.
1.2. **Adım 43:** Sıvı aspire edilir.

16. Sayım

1.1. **Adım 44:** Kompres sayımı yapılır.
1.2. **Adım 45:** Alet sayımı yapılır.
1.3. **Adım 46:** İğne sayımı yapılır.
1.4. **Adım 47:** Sayım doğrulanır.

17. Peritonun Kapatılması

1.1. **Adım 48:** Periton kenarları tutulur.
1.2. **Adım 49:** Periton **0 veya 1 Vicryl** ile kapatılır.

18. Kas Tabakasının Kapatılması

1.1. **Adım 50:** Kas tabakası uygun sütür ile kapatılır.

19. Fasya Kapatılması

1.1. **Adım 51:** Fasya kenarları hazırlanır.
1.2. **Adım 52:** Fasya **0 Prolen** ile kapatılır.

20. Cilt Altı

1.1. **Adım 53:** Cilt altı serum fizyolojik ile yıkanır.
1.2. **Adım 54:** Cilt altı **2/0 Vicryl** ile tek tek kapatılır.

21. Cilt Kapatılması

1.1. **Adım 55:** Cilt kenarları hizalanır.
1.2. **Adım 56:** Cilt **4/0 Polyamid** ile kapatılır.

22. Pansuman

1.1. **Adım 57:** Ameliyat sahası ıslak tampon ile temizlenir.
1.2. **Adım 58:** Steril gaz kompres yerleştirilir.
1.3. **Adım 59:** Pansuman sabitlenir.
1.4. **Adım 60:** Operasyon tamamlanır.

Her Adımda Kullanılan Alet Ve Ekipman

1.Adım:15 numara bistüri ucu (Bu bistüri ucu no:3 bistüri sapına takılır.)
2.Adım:Düz uçlu monopolar koter. (Elektrokoter kalemi)(Cut modunda)
3.Adım: Stille pensetle doku kenardan tutulur ve düz uçlu monopolar koter kalemi ile tabakalar açılır
4.Adım: Stille penset ve monopolar elektrokoter kalemi
5.Adım: Bistüri ucu değiştirilir. Yeni 15 numara bistüri ucu takılır. Stille penset kullanılır.
6.Adım:Sırasıyla mayo makası, pean klemp, stille penset ve pean klemp

7.Adım:Sırasıyla mayo makası, stille penset, moquito
8.Adım: Stille diseksiyon penset veya debukey diseksiyon penset.
9.Adım: Stille penset ve 15 no bistüri (Bistüri ucu değiştirilmesi gerekmez)
10.Adım: Stile penset ve mayo makası
11.Adım: Farabeuf ekartor veya roux ekartor
12.Adım: Farabeuf ekartor veya roux ekartor
13.Adım: Zayıf hastalarda farabeuf ekartör yada legenbeck ekartör – normal kilolu hastalarda legenbeck ekartör – daha geniş ekartasyon gerekirse Richardson ekartör
14.Adım: El manipülasyonu ile
15.Adım: Atraumatik babcock
16.Adım: Atraumatik babcock ve ıslak kompres
17.Adım: El ve göz ile (Palpasyon ve inspeksiyon)
18.Adım: Babcock
19.Adım: El ve göz ile (Palpasyon ve inspeksiyon)
20.Adım: Legenbeck 55x11mm (yapışıklık varsa)
21.Adım: Mayo makas veya elektrokoter (Yapışıklık varsa)(unipolar veya cut modda)
22.Adım: Atraumatik babcock + stille penset + Legenbeck 55x11mm
23.Adım: Mosquito klemp (Klemplenecek küçük damar adeti kadar) +
Pean klemp (klemplenecek daha kalın damar var ise adeti kadar) +
Portegü (bağlama yapacak ipliğin iğnesini tutmak için) +
Matzenbaum makası veya 15 numara bistüri (Dokuyu bağladıktan sonra ipliği kesmek için)
24.Adım: Matzenbaum makas + mosquito
25.Adım: Atraumatik babcock + stille penset + matzenbaum makas + legenbeck ekartör
26.Adım: Portegü + 3/0 ipek sütur
27.Adım: Portegü + stille penset + mayo makası(iplik için)*
28.Adım: Portegü + 2/0 vicryl + stille penset + mayo makası (iplik için)*
29.Adım: El ile
30.Adım: Babcock
31.Adım: 15 numara bistüri
32.Adım: Stille penset + 15 numara bistüri
33.Adım: Foerster klemp + 5x5 boyutlu spanç
34.Adım: 15 numara bistüri ucu yeni 15 numara bistüri ucu ile değiştirilir. No:3 bistüri sapı kullanılır.
35.Adım: Portegü + stille penset + mayo makası(iplik için)*
36.Adım: Portegü + stille penset (Dokunun tutulması gerekirse atraumatik babcock kullanılır.)
37.Adım: Portegü + stille penset + mayo makası(iplik için)*
38.Adım: Burada bir adet babcock formaldehit dolu kabın için ucundaki doku ile bıraklır.
39.Adım: Siteril olmayan teknikerin görevi.
40.Adım: İnspeksiyon ve palpasyon.
41.Adım: Elektrokoter (kuagülasyon modunda)
42.Adım: Sıcak iztonik + 50ml gavaj enjektörü (İzotonik masadaki metal tasa boşaltılır. Enjektöre çekilir ve hekime verilir)
43.Adım: Suction (cerrahi aspiratör) (yancouver aspiratör ucu)
44.Adım: Kompress sayımı
45.Adım: Alet sayımı
46.Adım: İğne sayımı

47.Adım: Sirküle steril alanın dışında söylenen sayımları elindeki liste ile onaylar yada eksiği söyler.
48.Adım: Stille penset (sıkı tutmak gerekirse mosquito)
49.Adım: Portegü + stille penset + vicryl 0 veya 1/0 iplik
50.Adım: Portegü + stille penset + vicryl 2/0 iplik
51.Adım: Stille penset (sıkı tutmak gerekirse mosquito)
52.Adım: Portegü + stille penset + 0 prolen iplik
53.Adım: 20 ml enjektör + izotonik
54.Adım: Stille penset + portegü + 2/0 vicryl iplik
55.Adım: Stille penset
56.Adım: Stille penset + portegü + 4/0 polyamid iplik
57.Adım: Islak kompres ile yara silinir.
58.Adım: 10x10 spanç yerleştirilir.
59.Adım: 15cm enindeki ipek flaster (bant) uygun uzunlukta kesilip yaranın üstüne konan spancın üstüne yapıştırılır.
60.Adım: Bitti.

Notlar

- İplik ve portegünün verildiği aşamalarda iplik portegünün ucuna yerleştirilmelidir
- Makaslar hariç parmakların geçmesi gereken yerleri olan aletlerin hepsi için kullanıcının başparmak ve orta parmağı – baş parmak ve yüzük parmağı kullanılmalıdır. İşaret parmağı aletlerim parmak yerleştirme bölümüne yerleştirilmez.

OLASI KOMPLİKASYONLAR